

2018 年 7 月 16 日（月）

GTA 3 期マスター 第 3 教程

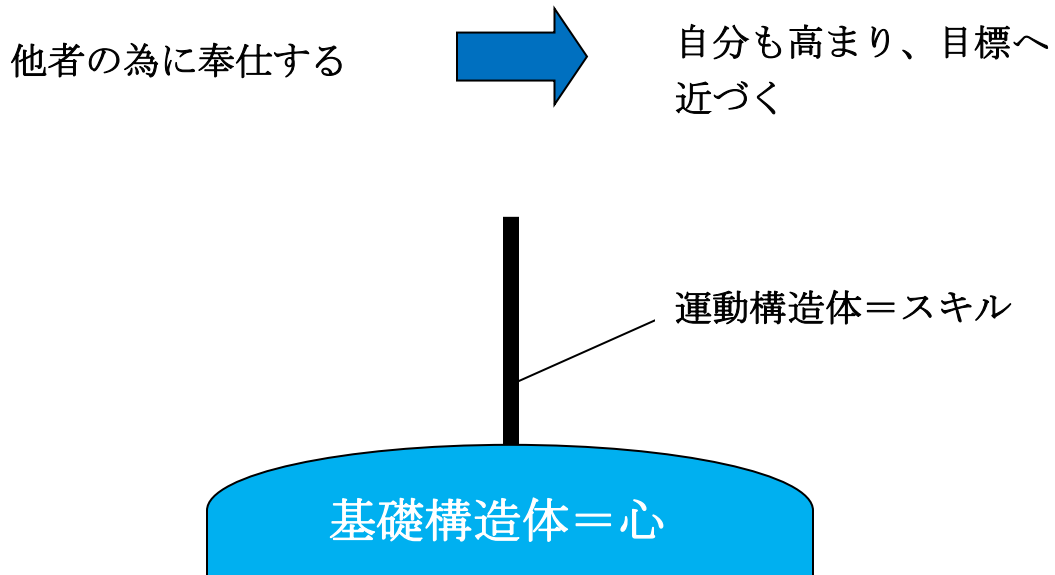
補助診断 VOL. 2

小林和哉

短時間睡眠でも大丈夫な身体づくり

1. 糖代謝にしない （糖代謝になると口が臭い、痰が臭くなる
 - 2食以上食べない → 理想は1日1食
 - 血糖値を上げない食べ方 （野菜→炭水化物は最後に！）
2. 頭部冷却 （**内頸動脈、椎骨動脈** → B2～B4、顔面）
 - 呼吸を確保して40分冷やす
 - S-Sleepだと寝ながら頸椎を水圧で治療できる
 - 外して10分寝ながら休む
3. 寝る前に2時間は携帯電話を見ない
 - どうしても見ないといけないときは**ナイトモード**にする
4. 家や院の照明はLEDにしない（※最近、LEDを使用するお店や電車が aumentando）
5. 夜遅くに、光がピカピカしたところに行かない
 - ネオン街
 - グループの整骨院
 - パチンコ屋
6. 朝に光をしっかりと浴びる、スマホ&PC作業をすます
7. 体力は歩いて作る → 3時間睡眠&5分間の昼寝に対応できるようになる

心を鍛え得を高める



- 基礎構造体である心があってこそスキルも上がっていく
- 普段から相手のことを思いやって行動する
e. g. トイレを使ったら綺麗にして出る
- 自然と出来るようになったらしめたもの

1500 万円行く！と決める → 常に How?, Why?, What? と考える、聞く

患者にしたらダメな人 → 時間を奪う人、周りに迷惑をかける人

スタッフ雇用条件 → ホウレンソウが出来る人

気持ちの良い挨拶をする → 語尾を上げて挨拶する

結果、相手も自分も気持ちがよくなり

「先生のところに行くと何か元気になる」と言われるようになる

SCT AS 検査

手順

1. 患者をベッド中央に仰向けに寝かせてお尻を上げて下ろしてリセット
下肢の回内、回外もリセット
2. 骨盤間をつたって WB に圧をかけていくため、左右の ASIS を押さずに手掌中央で触れるようにそえる



打ちこみの手円の形で触れる

3. WB 耳状面の奥 2～3cm のところにズーンと重たい感覚が出るのが陽性
抵抗感が出たらスッと抜ける感じ = ギャビング



仙腸関節の離解があるかないか触れて感じる

耳状面の離解があるとフワッと感じる→底なし沼のようなイメージ

陽性だと非荷重症および AS である可能性が高い

- 検査は 1 回だけ （潤滑して反応が出なくなる）
- 押すのではなく、垂直方向と水平方向の力を同時に 1 ずつ加える
- 重さでいうと 50g 以下、体格のいい人は 100g まで OK

禁忌： 初潮期、妊娠中、閉経期、硬いベッド

補助診断の補助： ASIS の少し下を押圧して痛ければ正常、感覚がない側は異常

PCT 検査

手順

1. ベッド中央にうつ伏せで寝てもらう
2. 術者は患者の上側にまたがり、PSIS 上を手掌で触れてあたりをつける

3～5cm ほど皮膚、皮筋を絞るようにどこかせながら、母指を 90 度立てて 45 度内方に回転させる

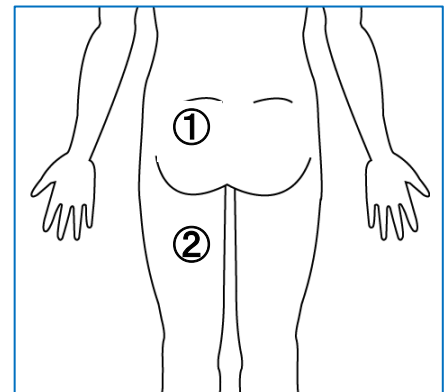


上腕から母指の先まで 1 直線になるように、自分の腕の重さ（5～6kg）で押していく

3. ① 押した直後から痛む → 骨膜反応＝新鮮な骨傷

外傷性の骨傷があることが判断できるが **PI-t** か？ **AS** か？これだけでは判断できない

出やすい人： 足腰の弱い人、
ドスンと座る人
片側のお尻からすわる人
振動系の乗り物に毎日乗る
(車、バイク、自転車、電車 etc.)



- ② 10 秒後に霧がかかるようにボーンとした方散痛のような反応が出て、離すと消えるのが特徴 → **PI-t 確定**

注意点

1. 仙骨神経には触れない！
痛みが残る場合仙骨神経を押してしまった可能性が大きい
2. 右 PI-t をかもしれないで処置すると生命ラインに影響が出る可能性がある
仮定でやってはいけない
3. AS の人に PI-t 治療 をすると AS がひどくなる
⇒（表面の AS を取らず、 PI-t を取ると落ち着かなくなる
4. 仙骨と腸骨の間に指をいれない！！
5. 女性にはタオルをかける配慮が必要 — リスクマネジメント、信頼感
6. PSIS が分かりにくい人は、腸骨稜の上からやさしく手繰でたどっていく

※全く歩いてない人（PSIS 周辺が組織変性してわかりにくい）

※AS きつい人 （PSIS 周辺が組織変性してわかりにくい）

※PSIS に外傷を受けてきた人

ルレット検査

3点検索型

- デルマトーム： **皮節**
- ミオトーム： **筋節**
- オステオトーム： **骨節**

適応外

中枢神経麻痺
脱髄
脱髄損傷
大きな火傷
オペの傷
重症のアトピー
皮膚の感覚異状

メリット

病院でもやらない検査なので、こちらの専門性を出せる → 骨格のエキスパート

判断の仕方

- 1) **非荷重系**：鈍磨（オブラードに包まれている感じ、100%ではない）
- 2) **外傷系**：初期は鈍磨
数日後からチクチク過敏になってくる（神経伝達亢進のため）
- 3) **知覚異常**：感じにくい、感覚の時差、くすぐったい

皮膚の問題

脳の感覚が精細ではない人は毎回違うことを言う

くすぐったがりの人は体にエネルギー（ダメージ）が蓄積している可能性大

聞き方

直接触れているか？ 膜につつまれているか？ で聞く

※知覚鈍麻、過敏がどこにあったのかをカルテに記入すること

持ち方



1. へこんでいる部分を軽く持つと重みで先端が45度下がる
2. その角度のまま引いて転がしていく重みを使って引く

※押すと転がらないし患者さんが無意味に痛がるので×（音も鳴らない）

【3点を触れて調べるようにする】

（2点では左右差しか分らない・基準点がないので何の判断つかない）

※体幹と感覚が近いのか異常なのか3点を比べる

《検査場所》

下肢

《基準点》

臍（へそ）の上

《比較部位》

下腿（腓骨→頸骨）

※ 下肢は外側から診る



下肢の知覚からみる骨盤

※ 脛骨の方が荷重対応が3 倍強い

※本来外側に荷重をかけないはずだが、外側ばかり使うとどうなるか？

初期は**外側**の知覚が過敏になる→ 長く外に煽って歩いているとだんだん**知覚がなくなっていく**ので知覚鈍麻になる→ AS 状態が長くなると非荷重症になる

→**非荷重症の人は外の知覚が鈍くなっている**

※内側がピリピリする⇒PI-t の人は内側に捻るのでより荷重をかけ続けるから**知覚が過敏になる**

《検査場所》

上肢

《基準点》

胸骨ライン

《比較部位》

前腕

※前腕は外側から診る



上肢の非荷重

手を使っていない（振っていない）

腕を伸ばして歩くと、前腕が抜けたような感じになり非荷重

腕を曲げて振ると引っ張られる作用で荷重がかかる

触れていない→筋肉が使われなくなっていく→骨が萎縮→血管が細くなる→毛細血管も細くなる→血が流れない→**冷え性（毛細血管網が発達していない）＝上肢の非荷重**

上肢の外傷（手をつく）

腰痛が長い人、力が弱く立ち上がる時に手をつく癖のある人

上記の理由により腰痛、膝痛の人は付帯症状として腱鞘炎、手根管症候群、ばね指などを併発している可能性がある。

→ **この人は手の影響でもれなく首（B2）も痛めるので首の治療も必要になる。**

《検査場所》

顔

《基準点》

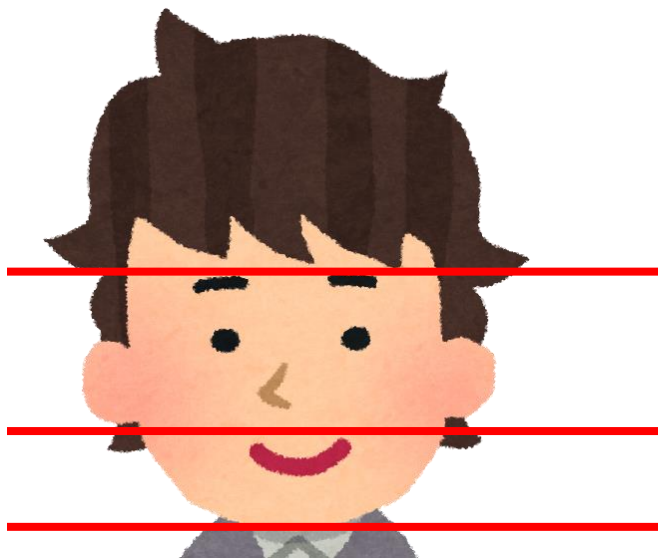
おでこの中心

《比較部位》

左右



C1



眉毛上＝アトラス異常

C2

眉毛～前歯 4 本上顎骨

C3

前歯 4 本～下顎まで

C4 は難しい→顔の知覚をとるほうが早い！！

損壊パターン：下から壊れていき、B2→C1→C3→C2 の順に壊れていく

そこからさらに B3 に影響がでて胸腰椎が動かなくなる→損壊どおりじゃない力（居眠り、頬杖 etc.）が入ると歯痛が起こる

肩 挙上テスト

手順

1. 患者は座位で背筋、腰伸ばす、足裏つく（股、膝、足関節 90°）
2. 母指を内側に出して、患者に挙上してもらう（自動運動）

《前方挙上》術者は患者の上腕をもって、肩関節の詰まり感、ひっかかりを診る

《後方挙上》術者は患者の前腕をもって、肩関節の詰まり感、ひっかかりを診る

《外転》手のひら上向きで外転してもらう（自動運動）
⇒上がらない場合は、腱板・三角筋・関節唇損傷の可能性
※外転で痛みが出る場合、肩単独に原因がある可能性大

【B2 とセットで診る】

B2 検査でレバーアームが出た側と反対側に肩前方挙上制限が出る
⇒ B2 由来（股関節の騒動関係）

例) **B2** 左レバーアーム
肩 右挙上制限

《相同関係性の問題を診る》

右 hip-P⇒左前方挙上制限
右 hip-A⇒左後方挙上制限
※痛みと検査は必ずしも一致しない

レバーアーム側に挙上制限⇒凍結肩で治療は長期（6 ヶ月以上）にわたる

チネルサイン



手順

1. 患者の手関節を背屈させる
2. 患者の手根管を術者の中指で軽く叩き、正中神経ラインに響く感じがあれば陽性

※チネル陽性は手関節**背屈制限**あり

※**基本的には B2 レバーアームの逆側に出る**

両側に出る場合

- a) 手関節の捻挫
- b) 四つ這いでベタ着きする人
- c) 手関節が壊れる

腰痛のある人、高齢者、掘りごたつの人などはしょっちゅう手をついて立つので手根管が壊れやすい ⇒ 手根管が壊れると手関節背屈ができなくなる

CTS（手根管症候群）＝ 構造障害

手根管自体を壊しているなので治るのに1 ヶ月～1 か月半、長いと6 ヶ月かかる

フィンケルシュタインテスト



ドケルバンの有無を調べる検査

ドケルバンは第一中手骨か舟状骨の浮上で発生する

手順

1. 患者に母指を握らせて
2. 術者は中枢に向かって押しながら尺屈
3. 伸びない・テンションが出る方が陽性（☆疼痛が出ている場合は伸びない）

※ 基本的には B2 レバーアームの同側に出る

※ 掌屈制限が出る側＝フィンケル陽性側

※ 確認として母子を握らなくても痛い場合は捻挫

※ 両側ドケルバンはない人：捻挫歴

大菱形骨、中手骨に骨折 or 脱臼が入ってる可能性あり

※ 分からない場合はルレットで知覚検査する

⇒（過敏な人、ピリピリする感覚があれば陽性の可能性）